

Praca jako *element zdrowienia*

IPS — model „*najpierw praca, potem trening*”. 60–80% sukces vs 15% w tradycyjnej rehabilitacji. Praca daje strukturę, sens, kontakt, tożsamość — nie tylko dochód.

CZAS: 10–15 min Po stabilizacji · z motywacją do pracy

ŹRÓDŁO: Becker & Drake (1993); Drake i in. (1999); Bond i in. (2008); Burns i in. (2007, EQOLISE)

JAK UŻYWAĆ

Zrozum **różnicę między IPS a tradycyjną rehabilitacją zawodową** (sekcja 1), poznaj **osiem zasad IPS** (sekcja 2) i zastanów się nad **swoimi preferencjami zawodowymi** (sekcja 3). W sekcji 4 — pierwszy konkretny krok.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Bond i in. (2008, meta-analiza 11 RCT z ~1500 osób): *Individual Placement and Support* (IPS) osiąga **61% sukcesu** w uzyskaniu zatrudnienia konkurencyjnego — vs 23% w tradycyjnej rehabilitacji zawodowej. Burns i in. (2007, badanie EQOLISE w 6 krajach EU): IPS jest **2,5x skuteczniejszy** od podejść tradycyjnych w warunkach europejskich. Założenie IPS przeciwne intuicji: „*najpierw praca, potem trening*” (nie „*trening, potem praca*”). Drake (1999): natychmiastowe umieszczenie w **prawdziwej pracy** z systematycznym wsparciem działa lepiej niż lata „*przygotowywania się*” w warsztatach terapii zajęciowej (skuteczność tradycyjnego modelu *train then place*: 5–15%).

01 ◎ IPS vs tradycyjna rehabilitacja

TRADYCYJNE · TRAIN THEN PLACE

Długie miesiące „*przygotowywania*” — warsztaty, próbne staże, terapia zajęciowa. Potem próba umieszczenia. Skuteczność: 5–15%. Często bez końcowej pracy konkurencyjnej. Pacjent traci motywację, zostaje w „*poczekalni*”.

IPS · PLACE THEN TRAIN

Szukanie pracy *od pierwszego dnia*. Trener pracy (ang. *job coach*) towarzyszy w rozmowach, adaptacji, kryzysach. **Skuteczność: 60–80%**. Motywacja w realnym kontekście. Konkurencyjne zatrudnienie na otwartym rynku.

02 📋 Osiem zasad IPS (Drake, 1999)

1. Cel: zatrudnienie konkurencyjne na otwartym rynku — nie warsztaty.

2. Każdy, kto chce pracować, może spróbować — brak kryteriów wykluczenia.

3. Szybkie szukanie pracy — od pierwszego miesiąca, nie po latach „*przygotowań*”.

4. Preferencje pacjenta kierują wyborem pracy — nie „*zdolności*” oceniane przez terapeutę.

5. Integracja z leczeniem — trener pracy jest częścią zespołu klinicznego.

6. Doradztwo finansowe — jak praca wpływa na rentę, świadczenia, podatki.

7. Bez limitu czasowego — wsparcie tak długo, jak potrzeba, nawet po latach pracy.

8. Systematyczny networking z pracodawcami — ukryty rynek pracy.

03

✎ Moje preferencje zawodowe

Praca nie musi być pełnoetatowa. Część etatu, wolontariat, staż — każda forma aktywności ma wartość. Wybierz to, co teraz wydaje się *najbardziej możliwe*, nie najbardziej ambitne.

CO LUBIĘ ROBIĆ

— co mnie interesuje, w czym dobrze się czuję

JAKIE WARUNKI POTRZEBUJĘ

— elastyczne godziny, spokojne miejsce, krótkie zmiany

JAKIE MOJE UMIEJĘTNOŚCI MOGĘ ZAOFEROWAĆ

— co już potrafię, w czym mam doświadczenie

CZEGO SIĘ OBAWIAM

— co mnie zatrzymuje, jakie wsparcie pomogłoby

04

💡 Co dostępne w Polsce

ZAZ

zakłady aktywności zawodowej

Praca z dostosowaniem do orzeczenia o niepełnosprawności. Stała pensja, krótszy czas pracy, dostosowane warunki.

WTZ

warsztaty terapii zajęciowej

Bardziej terapeutyczne niż zawodowe — przygotowanie do pracy. Mogą być pomocne, ale to *nie* jest IPS.

TRENERZY PRACY

w niektórych CZP, NGO

Pilotażowe wdrożenia IPS w Polsce. Pytaj psychiatrę o trenera pracy lub doradcę zawodowego specjalizującego się w psychiatrii.

Klucz: praca to *nie nagroda za wyzdrowienie* — to **część procesu zdrowienia**. Bond i in. (2008): osoby uczestniczące w IPS, nawet jeśli *nie* znalazły pracy, mają lepsze objawy, lepsze funkcjonowanie i wyższe poczucie własnej wartości. Sam *proces* ma wartość terapeutyczną. „*Nie czekaj, aż będziesz gotowy*” — gotowość przychodzi przez działanie, nie przed nim. Burns EQOLISE (2007): w 6 krajach europejskich (w tym Holandia, Niemcy, Wielka Brytania) IPS jest **standardem**. W Polsce — wciąż rzadkie wdrożenia, ale rosnący ruch. Spytaj psychiatrę o pilotażowe programy w Twoim mieście.